

إسم المريض رابعياً : فكرية محمد لطفى محمد

المحافظة : القليوبية

الحى / المدينة : شبرا الخيمة

العنوان : 0

تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

رقم البطاقة : 29010250104884 رقم التلفون : 01125890735

العمر(تاريخ الميلاد) : 25-10-1990 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- الموقع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فكرية محمد لطفى محمد National ID: 29010250104884	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
 بوزارة الداخلية
 بطاقة تعريف شخصية

رقمه
 محمد لطفي محمد
 هـ بن الحاج عاطف
 بشرا النجعة أول - القليوبية

٢٩٠١٠٢٥٠١٠٤٨٨٤

JA2908747

٢٠٢١/٠٨ ٢٩٠١٠٢٥٠١٠٤٨٨٤
 ربة منزل
 انتي مسلمة
 اسلام مختار حسن محمد
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٩

ملاحظة

١



C9.1.C0.1. ΣΑΝΣ

BIOT FORM

19 / 6 / 2025 G

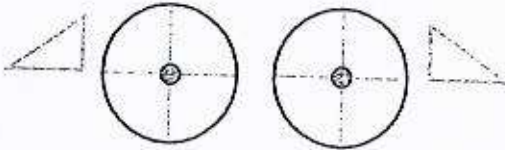
<u>Name</u>	120 (5th 1204) 19	<u>MRN</u>	4253
<u>Age</u>	34 yrs	<u>ID</u>	2024
<u>Menopausal status</u>	Pre menopause	<u>Phone</u>	011 25890735
<u>NRS SCORE</u>		<u>Marital status</u>	m
<u>BMI</u>		<u>Family history</u>	irrelevant
<u>CO morbidity</u>	irrelevant	<u>REASON OF MDT</u>	Post OP

Clinical Data

BX: IDC			
ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: +ve	Ki67: 40
Sonomammography: Post NACT			
Mets Workup: Right BC S & SLN/B (Post NACT) No residual tumor Free margins Free lymph nodes (0/4)			

R

round is *ben*.^L



TNM
200

Recommendations:

Recommendations:
pathologic Complete response.

MDT OUTCOME & PLAN

for PORT
+ herceptin SQ single agent
+ TAM X 2yrs then AI + Zoled

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Patient Name : الأستاذ / فكريه محمد لطفى محمد
Patient No. : 29010250104884
Path No. : 1929/25
Sex : Female
Age : 34 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008324
Request Date : 27/05/2025
Verification Date : 11/06/2025
Financial Category : اورام دار السلام - مبادئ
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

CLINICAL DATA: Right breast cancer, post NACT

NATURE OF SPECIMEN: Right BCS&SLNB

GROSS EXAMINATION:

• Procedure: Right BCS & SLNB

Fibrofatty tissue piece measured 8x4x2 cm with No covering skin ellipse

• Tumor extent : A greyish white tumour bed site

• Size: 4x2x1 cm .

• Skin involvement: Unremarkable grossly .

• Distance from margins:

• 0.5 cm away from least margin (lateral, superior, superficial margins)

• away from medial & inferior by 2.5 cm

• Sentinel lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 4x3x1.5 cm entangling 4 nodules up to 1x1 cm

• Frozen section: Free margins & free SLNB (0/4)

MICROSCOPIC EXAMINATION:

• Histological type: No residual tumor

• Ductal carcinoma in situ: No

• Lymph nodes: Free lymph nodes (0/4)

• Skin involvement: Free

• Resection margins: Free margins

• Histologic response to therapy: Pathologic complete response

DIAGNOSIS:

Right BCS & SLNB (post NACT) :

No residual tumor

• Free margins

• Free lymph nodes (0/4)

• Pathologic Complete response (PCR)

• Stage : ypT0,ypN0

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 14/06/2025 10:57:04

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

شركة (4) - شارع (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 987 - Nile Corniche - New El Qadima - Cairo, Egypt

Name : FEKREYA MOHAMED LOTFY

Date : 11-01-2026 11:37

Branch : Portable

Medical No. : GRI-94335

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

CT chest, abdomen and pelvis with contrast

Previous Exams:

- This is the baseline metastatic work-up,
- No available medical or clinical data and no previous images.

FINDINGS:

• **Chest:**

- *Right breast outer quadrant parenchymal nodules ... for sono-mammographic correlation.*
- *Right para-cardiac nodular septal thickening ... for clinical correlation.*
- *No focal mass lesions or consolidative patches*
- The trachea is central in position.
- No mediastinal mass lesions, normal enhancement of the mediastinal vessels.
- No suspicious mediastinal or hilar lymph nodes.
- Normal pleural thickening with no pleural collections identified.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion.

• **Abdomen:**

- The liver shows normal size and density with no enhancing focal hepatic lesions.
- Normal size and density for the spleen with no enhancing focal mass lesions.
- The pancreas shows normal size with no ductal dilatation or enhancing focal mass lesions.
- Normal appearance of the supra renal glands bilaterally.
- Both kidneys show normal size with no suspicious mass lesions. Intact parenchymal thickness, no renal stones or back pressure changes,
- Normal ureters with no hydronephrotic changes.
- Scans through the pelvis show no mass lesions.
- No suspicious enlarged abdominal or pelvic lymph nodes. No ascites.

Opinion: Limited study for no available any medical reports or any medical data

- ✦ **Right breast outer quadrant parenchymal nodules ... for sono-mammographic correlation.**
- ✦ **Right para-cardiac nodular septal thickening ... for clinical correlation.**
- ✦ **Unremarkable abdominal and pelvic study with contrast.**

Thanks for referral;

Dr. Reham Mohamed, MS., FRCR.

Dr. Reham Elhusien

Patient Name: Fekreya Mohamed Lotfy Mohamed	Date : 19/11/2025
Exam : ultrasound TRANS VAGINAL	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 4253/2024	Pat. ID: 94335

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed: -

○ **Uterus: -**

- *RVF, average size uterus measuring about: 8x4x4cm in its longitudinal, transverse & AP diameters respectively.*
- *The myometrium shows homogenous texture with no focal lesion*
- *The endometrial line is 10mm showing tiny cystic areas, IUCD is in place for follow up*

○ **Ovaries: -**

- *Both ovaries are average size with no focal lesion*
- *No gross adnexal soft tissue masses or cysts.*
- *No free fluid in the Douglas pouch.*

Signature Dr . Nermien Ramadan
19/11/2025 12:15 PM

Patient Name: Fekreya Mohamed Lotfy Mohamed	Date : 19/11/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 4253/2024	Pat. ID: 94335

Bilateral high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post Right CBS and SLNB followed by radiotherapy, on adjuvant hormonal and targeted therapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast,

- Preserved fibroglandular pattern.
- UOQ , 10 o'clock, posterior third area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 3.5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.
- No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast,

- Preserved fibroglandular pattern.
- UOQ , 2 o'clock, anterior third, para-areolar, 13 mm deep to the skin, circumscribed oval parallel homogenous hypoechoic benign looking solid mass lesion with absent posterior characters or internal vascularity on color doppler study measuring 10 x 4 mm.
- No cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequelae.

Left breast (BIRADS 3): UOQ probably benign solid mass lesion mostly fibroadenoma.

Recommendation:-

For US follow up in three months as it was not mentioned at the available latest available radiological data.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations

Suspected Cancer Risk

BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routine screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignancy.	

Name: Mrs. FEKRYA MOHAMED

Date: 3-12-2025

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post Right CBS, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ, posterior third architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated UOQ posterior third area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 3.5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Uoq ill-defined density .
- Ultrasound demonstrated stationary course of previously noted 2 o'clock mass lesion measures 9 x 4 mm in today's study.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequelae.

Left breast (BIRADS 3): stationary 2 o'clock probably benign mass lesion .

Recommendation:-

For us follow up after 6 months .

Best Regards,
DR. RANIA AHMED, MD

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

<u>Category & recommendations</u>	<u>Suspected Cancer Risk</u>
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routine screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	